

TEMA 2.3 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Diabetes en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 1.04.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diabetes en el Embarazo: Gestacional vs. Pregestacional

Conceptos Clave

- **DM Gestacional (DMG):** se diagnostica durante el embarazo (después de la semana 12)
- **DM Pregestacional (DMPG):** diagnóstico previo al embarazo o diagnóstico en las primeras 12 semanas con criterios de no-embarazada
- **En el embarazo no existe la prediabetes** → cualquier valor elevado ya es DMG

Criterios Diagnósticos en el Embarazo

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)

TABLA 2.3.1: EXAMEN VS CORTE DIAGNÓSTICO	
EXAMEN	CORTE DIAGNÓSTICO
Glicemia de ayuno	≥ 100 mg/dL (en 2 ocasiones)
TTOG 2h (75g) — basal	≥ 100 mg/dL
TTOG 2h (75g) — 2 horas	≥ 140 mg/dL

Diabetes Mellitus Pregestacional (DMPG)

- Diagnóstico previo al embarazo, **O**
- En primeras ≤ 12 semanas con criterios de persona no embarazada (glicemia ≥ 126 o ≥ 200 + síntomas)

Screening en el Embarazo

''' Inicio del embarazo → Glicemia de ayuno |— < 100 → Normal → Repetir TTOG entre semanas 24–28 |— ≥ 100 → Repetir directamente → Si ≥ 100 de nuevo: DMG

Semanas 24–28 → TTOG 75g |— Basal < 100 + 2h < 140 → Normal |— Cualquier valor fuera del corte → DMG '''

Factores de riesgo que obligan a repetir TTOG a las 32–34 semanas

- Feto grande para la edad gestacional (GEG)
- Polihidramnios
- DMG en embarazo anterior

Diferencias de los criterios según momento del embarazo

TABLA 2.3.2: SEMANAS DE EMBARAZO VS GLICEMIA 105 AYUNO		
SEMANAS DE EMBARAZO	GLICEMIA 105 AYUNO	DIAGNÓSTICO
No embarazada	100–125	Glicemia de ayuno alterada → pedir TTOG
≤ 12 semanas	100–125	DMG (≥ 100 → repetir)
> 12 semanas	100–125	DMG (mismos cortes que gestacional)
≤ 12 semanas y glicemia ≥ 126	130	DMPG (criterio no-embarazada)

| > 12 semanas y glicemia ≥ 126 | 130 | **DMG** (ya pasaron las 12 semanas) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Embarazada de 10 semanas con glicemia de ayuno de 108 mg/dL confirmada en una segunda toma. ¿Cual es el diagnostico mas probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diabetes en el Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En embarazo NO existe prediabetes: ni glicemia de ayuno alterada ni intolerancia a la glucosa oral.
- Diabetes gestacional: glicemia de ayuno mayor o igual a 100 (no 126), TTGO poscarga mayor o igual a 140 (no 200).
- Diabetes pregestacional: diagnostico previo o criterios de no embarazada en primeras 12 semanas.
- Screening: glicemia de ayuno al inicio. Mayor o igual a 100 se repite directamente (no TTGO).
- TTGO de 75 gramos entre 24-28 semanas. Factores de riesgo: repetir a 32-34 semanas.
- Diferencia clave con no embarazada: cortes de glicemia son mas estrictos porque la hiperglicemia leve ya dana al feto.
- Glicemia 100-125 en embarazada = diabetes gestacional. En no embarazada = glicemia de ayuno alterada.
- Mayor o igual a 126 en primeras 12 semanas = pregestacional. Despues de 12 semanas = gestacional.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIABETES EN EL EMBARAZO)

PREGUNTA 1

Embarazada de 10 semanas con glicemia de ayuno de 108 mg/dL confirmada en una segunda toma. ¿Cual es el diagnostico mas probable?

- ☐ A) Glicemia de ayuno alterada
- ☐ B) Diabetes mellitus gestacional
- ☐ C) Diabetes mellitus pregestacional
- ☐ D) Normal, no requiere estudio
- ☐ E) Prediabetes del embarazo

PREGUNTA 2

Embarazada de 8 semanas con glicemia de ayuno de 132 mg/dL. ¿Cual es el diagnostico mas probable?

- ☐ A) Diabetes mellitus gestacional
- ☐ B) Diabetes mellitus pregestacional
- ☐ C) Intolerancia a la glucosa
- ☐ D) Resistencia a la insulina fisiologica
- ☐ E) Normal para el embarazo

PREGUNTA 3

Embarazada de 26 semanas se realiza TTGO de 75 gramos. Glicemia basal 95 mg/dL, poscarga a las 2 horas 155 mg/dL. ¿Cual es el diagnostico?

- ☐ A) Normal
- ☐ B) Intolerancia a la glucosa oral
- ☐ C) Diabetes mellitus gestacional
- ☐ D) Diabetes mellitus pregestacional
- ☐ E) Glicemia de ayuno alterada

RESUMEN: DIABETES EN EL EMBARAZO

El diagnostico de diabetes en el embarazo cambia significativamente respecto a la persona no embarazada. En el embarazo no existe la prediabetes: ni la glicemia de ayuno alterada ni la intolerancia a la glucosa oral, ya que esos rangos de glicemia ya pueden generar complicaciones fetales. La diabetes mellitus gestacional se diagnostica con: dos glicemias de ayuno mayor o igual a 100 (ya no 126), un TTGO de 75 gramos con basal mayor o igual a 100 o poscarga a las 2 horas mayor o igual a 140, o glicemia mayor a 200 mas sintomas. La diabetes pregestacional requiere diagnostico previo al embarazo, o cumplir criterios de persona no embarazada (glicemias mayor o igual a 126 o glicemia mayor a 200 con sintomas) dentro de las primeras 12 semanas. El screening se hace con glicemia de ayuno al inicio del embarazo. Si es menor a 100, normal. Si es mayor o igual a 100, se repite directamente (no se pide TTGO como en no embarazadas). Entre las 24-28 semanas se pide un TTGO de 75 gramos. Si hay factores de riesgo como feto grande o diabetes gestacional previa, se repite el TTGO a las 32-34 semanas.